ICS 11.020
CCS C 05

DB 13

河 北 省 地 方 标 准

DB 13/T 6030—2024

成人慢性疼痛护理规范

2024－10－28 发布　　2024－11－28 实施

河北省市场监督管理局　　发 布

前　　言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则　第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由河北省卫生健康委员会提出。

本文件由河北省卫生健康标准化技术委员会（HeB/TC 25）归口。

本文件起草单位：河北医科大学第二医院。

本文件主要起草人：张丽华、时宏琛、于宏伟、曹金婷、杜玉敏、任玉娥、高俊香、刘广召。

成人慢性疼痛护理规范

1 范围

本文件规定了成人慢性疼痛护理的总体要求、评估、护理和健康教育。
本文件适用于各级各类医疗机构的护理人员。

2 规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

疼痛 pain

一种与实际或潜在的组织损伤相关的不愉快的感觉和情绪情感体验，或与此相似的经历。

3.2

慢性疼痛 chronic pain

持续时间超过组织修复愈合所需时间或超过3个月以上的疼痛。

3.3

患者自控镇痛 patient controlled analgesia

一种使用自控镇痛装置给药的技术，患者可根据镇痛需要，自行给予医生预先设定剂量的止痛药物，以满足个体化镇痛需求。

4 缩略语

下列缩略语适用于本文件。

NRS：数字评分法（numeric rating scale）
VRS：语言评分法（verbal rating scale）
VAS：视觉模拟评分法（visual analogue scale）
FPS-R：改良面部表情疼痛评估工具（faces pain scale-revised）
BPI：简明疼痛评估量表（the brief pain inventory）
BPS：成人疼痛行为评估量表（behavioral pain scale）
PCA：患者自控镇痛（patient controlled analgesia）

5 总体要求

5.1 疼痛评估应以患者的主诉为依据，选择适用的疼痛评估工具，进行常规、量化、全面、动态的评估。
5.2 遵医嘱用药应及时、准确、规范，监测镇痛效果并观察不良反应。
5.3 应对患者和主要照顾者进行疼痛相关知识教育，并鼓励其共同参与疼痛管理。
5.4 宜建立由医师、药师、护士、心理治疗师等成员组成的多学科团队，共同管理患者。

6 评估

6.1 评估内容

6.1.1 疼痛评估包括疼痛部位、程度、性质、发生与持续时间、伴随症状、诱发因素、缓解因素。
6.1.2 全面疼痛评估除包括 6.1.1 规定的内容之外还包括：心理状况及家庭社会支持情况、对日常

生活的影响、既往的镇痛治疗方法、治疗效果和副反应、全身情况。

6.2 评估时机

6.2.1 对新入院患者应 8 小时内完成疼痛评估，24 小时内完成全面疼痛评估。

6.2.2 轻度疼痛每日进行一次疼痛评估，中、重度疼痛每日进行 2~3 次疼痛评估。

6.2.3 患者特殊治疗后、出现新发疼痛、疼痛性质或镇痛方案改变时、镇痛措施实施后应进行疼痛评估。

6.3 疼痛评估方法

6.3.1 疼痛程度自评

6.3.1.1 理解数字并能表达疼痛的患者可用数字评分法（NRS），具体要求见 A.1.1。

6.3.1.2 理解文字并能表达疼痛的患者可用语言评分法（VRS），具体要求见 A.1.2。

6.3.1.3 不能理解数字和文字的患者可用视觉模拟评分法（VAS ），具体要求见 A.1.3。

6.3.1.4 不能理解数字和文字的患者，或不能用语言正常表达的患者，可用改良面部表情疼痛评估工具（FPS-R），具体要求见 A.1.4。

6.3.2 疼痛程度他评

不能使用自评工具评估疼痛程度的成人患者可用成人疼痛行为评估量表 （BPS），具体要求见 A.2。

6.3.3 疼痛全面评估

成人患者进行疼痛全面评估可用简明疼痛评估量表（BPI），具体要求见A.3。

7 护理

7.1 依据疼痛评估结果，宜采取临床、药学、康复、心理、中医等多学科联合与患者自我管理相结合的综合干预模式。

7.1.1 用药护理包括药物规范应用、药物指导，药物不良反应识别、预防及处理见附录 B。

7.1.2 使用 PCA 泵预防或控制疼痛时，应每班检查 PCA 泵，确保管路固定妥当，仪器运行正常；每班评估镇痛效果，观察有无肢体麻木或肌力进行性下降等潜在并发症的发生；指导患者在疼痛时按压自控键。

7.1.3 康复及中医干预措施包括按摩、经皮电刺激、银质针导热疗法、冲击波、红外光照射治疗、针灸等。

7.1.4 心理干预包括情绪调节、正念减压疗法、放松训练、音乐疗法、催眠等。

7.1.5 疼痛自我管理包括疼痛认知与评估、药物和非药物镇痛相关知识、功能锻炼和生活方式改变、接受教育和心理干预等。应鼓励患者及家属运用书籍、培训课程、团体活动、互联网或移动应用等方法参与疼痛自我管理。

7.2 应及时评价镇痛效果，没有得到控制的重度疼痛应立即处理。

7.3 指导患者定期复诊或遵医嘱随访。

8 健康教育

8.1 应鼓励患者主动报告疼痛。

8.2 应指导患者正确使用自评疼痛评估工具。

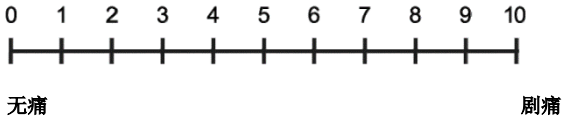
8.3 应告知患者和主要照护者非药物和药物镇痛的方法、常见不良反应及出现不适及时告知医护人员。

8.4 应告知患者和主要照护者做好风险防范与安全管理，包括防跌倒、坠床、非计划拔管等不良事件发生。服药期间应避免驾驶车辆、操作机器或高空作业等。

附　录　A
（资料性）
疼痛评估工具

A.1　疼痛程度自评工具

A.1.1　NRS 可用于理解数字并能表达疼痛的患者。疼痛程度用0~10共11个数字表示，0表示无痛，10表示最剧烈的疼痛；数字越大，疼痛程度越重。由患者根据其疼痛程度选择相应的数字，如图1所示。

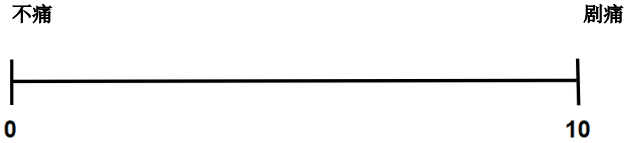


图A.1　数字评分法(NRS)

A.1.2　VRS 可用于理解文字并能表达疼痛的患者。0级无痛；1级轻度疼痛：有疼痛但可忍受，不影响睡眠；2级中度疼痛：疼痛明显，不能忍受，要求使用镇痛药物，疼痛影响睡眠；3级重度疼痛：疼痛剧烈，不能忍受，须用镇痛药物，严重影响睡眠。

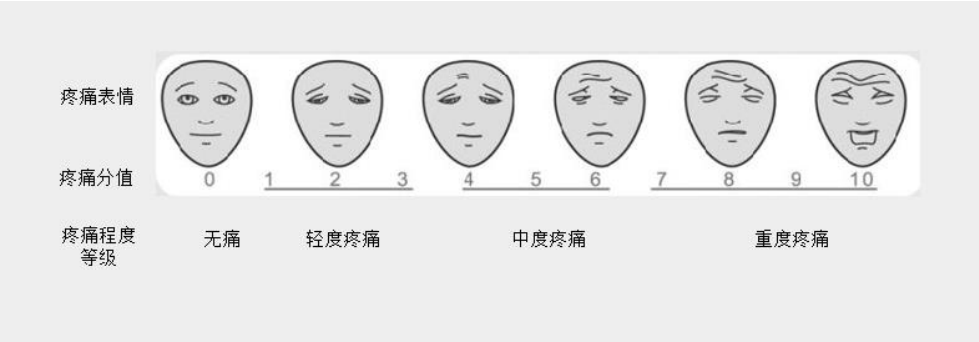
注：VRS 的4级疼痛对应 NRS 的得分分别是无痛（0分）、轻度疼痛（1-3分）、中度疼痛（4-6分）、重度疼痛（7-10分）。

A.1.3　VAS 可用于不能理解数字和文字的患者。用一条直线，不作任何划分，仅在直线的两端分别注明“不痛”和“剧痛”，请患者根据自己对疼痛的实际感觉在直线上标记疼痛的程度，如图2所示。



图A.2　视觉模拟评分法(VAS)

A.1.4　FPS-R 可用于不能理解数字和文字的患者，或不能用语言正常表达的患者。由患者选择最能表达其疼痛程度的面部表情，如图3所示。



图A.3　改良面部表情疼痛评估工具(FPS-R)

A.2 疼痛程度他评工具

BPS 用于不能使用自评工具评估疼痛程度的成人患者。每项按0-2评分，总分0-10分，数值越大说明疼痛程度越重，如表1所示。

表1 成人疼痛行为评估量表(BPS)

项目	数值		
	0	1	2
面部表情	放松	有时皱眉、紧张或淡漠	经常或一直皱眉，扭曲，紧咬
休息状态	安静	有时休息不好，变换体位	长时间休息不好，频繁变换体位
肌张力	放松	增加	僵硬，手指或脚趾屈曲
安抚效果	不需安抚	分散注意力能安抚	分散注意力很难安抚
发声（非气管插管患者）	无异常发声	有时呻吟、哭泣	频繁或持续呻吟、哭泣
通气依从性（气管插管患者）	安全耐受	呛咳，但能耐受	对抗呼吸机

A.3 疼痛全面评估工具

简明疼痛评估量表（BPI） 用于成人患者进行疼痛全面评估，具体样式见图A.4。

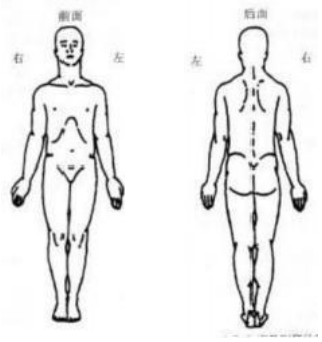
患者姓名： 病案号： 诊断：

评估时间： 评估者：

1、大多数人一生中均有过的疼痛经历(如轻微头痛、扭伤后痛、牙痛)。 除上述常见的疼痛外，现在您是否还感到有其他类型的疼痛?

(1)是 (2)否

2、请您在下图中标出您的疼痛部位，并在疼痛最剧烈的部位以“X” 标出。



3、请选择下面的一个数字，以表示过去 24 h 内您疼痛最剧烈的程度。

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

（无痛） （能够想象的最剧烈疼痛）

4、请选择下面的一个数字，以表示过去 24h 内您疼痛最轻微的程度。

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

（无痛） （能够想象的最剧烈疼痛）

5、请选择下面的一个数字，以表示过去 24h 内您疼痛的平均程度。

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

（无痛） （能够想象的最剧烈疼痛）

6、请选择下面的一个数字，以表示您目前的疼痛程度。

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

（无痛） （能够想象的最剧烈疼痛）

7、您希望接受何种药物或治疗控制您的疼痛?

8、在过去的 24 h 内，由于药物或治疗的作用，您的疼痛缓解多少?请选择下面的一个百分数，以表示疼痛缓解的程度。

（无缓解）0 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%（完全缓解）

9、请选择下面的一个数字，以表示过去 24 h 内疼痛对您的影响

1)对日常生活的影响

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

（无影响） （完全影响）

2)对情绪的影响

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

（无影响） （完全影响）

3)对行走能力的影响

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

（无影响） （完全影响）

4)对日常工作的影响(包括外出工作和家务劳动)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

（无影响） （完全影响）

5)对与他人关系的影响

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

（无影响） （完全影响）

6)对睡眠的影响

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

(无影响) (完全影响)

7)对生活兴趣的影响

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

(无影响) (完全影响)

图A.4 简明疼痛评估量表（BPI）(续）

附　录　B
（资料性）
慢性疼痛常用药物主要不良反应

B.1　慢性疼痛常用药物主要不良反应见表 B.1。

表B.1　慢性疼痛常用药物主要不良反应列表

药物分类	药品名称	主要不良反应
非甾体抗炎药	阿司匹林	胃肠道反应、过敏、血小板减少、肝肾毒性、中枢神经系统反应
	吲哚美辛	胃肠道反应、中枢神经系统反应
	布洛芬	胃肠道反应、血小板减少、肝肾毒性
	双氯芬酸	胃肠道反应、中枢神经系统反应、心脏毒性
	酮洛酸	中枢神经系统反应、胃肠道反应
	美洛昔康	胃部不适、腹泻、便秘、头晕
	塞来昔布	胃肠道反应：上腹部疼痛、腹泻和消化不良
	对乙酰氨基酚	肝肾毒性
类阿片类镇痛药	曲马多	出汗、恶心、呕吐、食欲缺乏、头晕、无力、嗜睡等
阿片类镇痛药	可待因	便秘、呕吐
	地佐辛	恶心、呕吐、镇静、头晕、厌食、定向力障碍、幻觉、呼吸抑制
	羟考酮	便秘、恶心、呕吐、瘙痒、头晕、头痛、口干、多汗、呼吸抑制、抑制胃肠蠕动和自主神经系统的影响
	布托啡诺	嗜睡、头晕、恶心、呕吐
	芬太尼	眩晕、视物模糊、恶心、呕吐、低血压、胆道括约肌痉挛、喉痉挛及出汗、呼吸抑制
	吗啡	呼吸抑制、恶心、呕吐、便秘、尿潴留、成瘾性、低血压及晕厥、缩瞳
离子通道调节剂	卡马西平	视物模糊、复视、眼球震颤、骨髓抑制、过敏性肝炎、皮疹
	奥卡西平	乏力、头晕、头痛、嗜睡、复视、眼震、共济失调、胃肠功能障碍、皮疹
	加巴喷丁	嗜睡、眩晕、步态不稳、疲劳感、周围性水肿
	普瑞巴林	眩晕、嗜睡
抗抑郁/抗焦虑药物	阿米替林	多汗、口干、视物模糊、排尿困难、便秘、嗜睡、震颤、眩晕、直立性低血压
	度洛西丁	食欲下降、便秘、恶心、呕吐、眩晕、口干、镇静、腹泻、出汗
局部麻醉药物	利多卡因	头晕、眼花、耳鸣、寒战、局麻药中毒反应
	布比卡因	头痛、恶心、呕吐、尿潴留、心率减慢
	罗哌卡因	恶心、头晕、头痛、晕厥等局麻药中毒反应
	氯普鲁卡因	焦虑、眩晕、耳鸣、视物模糊、震颤、晕厥
神经破坏药物	乙醇	运动神经、感觉神经破坏
肌肉松弛药物	乙哌立松	皮疹瘙痒、头痛、肌张力降低、运动障碍、视物模糊
	巴氯芬	肌张力降低、运动障碍、视物模糊
	替扎尼定	肌张力降低、运动障碍、视物模糊

B.2　慢性疼痛常用药物主要不良反应的预防及处理见表 B.2。

表B.2　慢性疼痛常用药物主要不良反应的预防及处理

不良反应类型	预防及处理
胃肠道反应	1.监测高危人群：年龄＞60岁，既往有消化道出血、溃疡、长期使用大量非甾体抗炎药的患者，应告知医生谨慎用药。 2.用药期间应观察患者有无消化道出血及胃肠不适症状，如便血、恶心、腹痛等。 3.对于长期使用非甾体抗炎药的患者应关注患者血常规、出凝血功能、大便隐血检查结果，异常者应及时通知医生停药。 4.不应同时使用2种及以上非甾体抗炎药，且不宜与抗凝药物并用。 5.应遵医嘱加用胃粘膜保护剂减少胃肠道的损害，尽量选择不良反应较小的非甾体抗炎药。
肝肾毒性	1.监测高危人群：年龄＞60岁，高血压、糖尿病、体液失衡、使用加重肝肾毒性药物的患者，应告知医生谨慎用药。 2.用药期间应关注患者肝肾功能检查结果。
心脏毒性	1.监测高危人群：年龄＞60岁，高血压、心力衰竭（如体液潴留和水肿）病史的患者，应告知医生谨慎用药。 2.用药期间观察有无血压升高、心悸等症状。
中枢神经系统反应	1.指导患者用药期间如出现头痛、头晕、眩晕等症状，及时报告医护人员。 2.服用药物期间，出现中枢神经系统症状者，应卧床休息，预防跌倒、坠床等，应避免驾驶、操作机械、高空作业等。
便秘	1.应用阿片类药物期间，应每日评估排便情况，及早发现便秘征象。 2.应遵医嘱预防性给予缓泻药物。 3.宜指导患者摄入充足的水分及膳食纤维并适当运动，规律排便。 4.指导患者腹部顺时针环状按摩、配合耳穴贴压、穴位贴敷等预防便秘。 5.应依据便秘严重程度，遵医嘱对症处理。
恶心呕吐	1.应根据患者恶心呕吐严重程度，遵医嘱使用止吐药。 2.水电解质紊乱的患者，应遵医嘱及时纠正并维持内环境稳定。
尿潴留	1.出现尿潴留者，应遵医嘱导尿，留置导尿管患者应执行留置导尿管护理常规。 2.此外可以选择训练排尿、针灸、听流水声诱导排尿、热敷会阴部、物理疗法等辅助缓解尿潴留。
呼吸抑制	1.应立即给氧、气道管理、建立液路，遵医嘱使用纳洛酮等药物。
药物依赖	1.与中枢镇静剂（如地西泮等）合用时需减量。 2.长期使用需评估产生耐药性或药物依赖性的可能。有药物滥用或依赖性倾向的患者应短期使用。

参 考 文 献

[1]徐晓林,胡晓晓,朱永洁,韩艳,李海燕.护理信息化平台规范化疼痛管理对住院患者疼痛管理质量的影响[J].国际护理学杂志,2022,41(16):2886-2889.DOI:10.3760/cma.j.cn221370-20200903-00732.
[2] 慢性疼痛分类目录和定义[J].中国疼痛医学杂志,2021,27(1):2-8.DOI:10.3969/j.issn.1006-9852.2021.01.002.
[3] 王彩霞,黄媛馨,王林.运动疗法在慢性疼痛中的研究进展[J].中国疼痛医学杂志,2024,30(4):296-301.DOI:10.3969/j.issn.1006-9852.2024.04.008.
[4] 杜成欣,张伟伟,许丽媛,樊碧发,董建群,颜流霞,姜莹莹.我国3省市门诊中老年慢性疼痛病人的流行特征分析[J].中国疼痛医学杂志,2024,30(5):341-347.DOI:10.3969/j.issn.1006-9852.2024.05.004.
[5]谭启香,张远兰,罗红.患者疼痛评估及其护理对策[J].中国护理管理,2010,10(12):78-80.DOI:10.3969/j.issn.1672-1756.2010.12.029.
[6] 史舒婷,符秋燕,邱宇欢,杨敏烈,朱利红.老年慢性疼痛的管理研究现状[J].护理实践与研究,2022,19(9):1307-1311.DOI:10.3969/j.issn.1672-9676.2022.09.011.
[7] 陈佳佳,童莺歌,刘冬华.国内外5项疼痛管理质量评审标准的比较[J].护理学杂志,2016,31(11):56-60.DOI:10.3870/j.issn.1001-4152.2016.11.056.
[8] 单文倩,胡凯文,顾柯,张金华.美国国家综合癌症网络成人癌痛临床实践指南解读[J].中国临床医生杂志,2022,50(1):30-32.DOI:10.3969/j.issn.2095-8552.2022.01.009.
[9] 李夏卉,李继平,杨帆.老年人慢性疼痛健康教育研究进展[J].上海护理,2020,20(12):49-52.DOI:10.3969/j.issn.1009-8399.2020.12.012.
[10]吕岩,周华成,林夏清,吴莹.慢性原发性疼痛[J].中国疼痛医学杂志,2021,27(2):81-86.DOI:10.3969/j.issn.1006-9852.2021.02.001.
[11] 杜涛,袁文茜,曹伯旭,胡永生,卢光,李俊驰,赵序利.慢性神经病理性疼痛[J].中国疼痛医学杂志,2021,27(7):481-485.DOI:10.3969/j.issn.1006-9852.2021.07.001.
[12] 吴丹,胡雅,李丽君,袁甜,刘丽华.老年人衰弱与慢性疼痛关系的研究进展[J].护理研究,2021,35(15):2738-2741.DOI:10.12102/j.issn.1009-6493.2021.15.022.
[13] 吴宣,赵欣茹,刘义兰,鲁才红,胡梦云,郑晓丹.护士疼痛评估循证护理实践现状及影响因素分析[J].护理学杂志,2020,35(5):66-68.DOI:10.3870/j.issn.1001-4152.2020.05.066.
[14] 王岚,李扬.疼痛护理中存在的问题及应对策略[J].中国实用护理杂志,2012,28(3):20-22.DOI:10.3760/cma.j.issn.1672-7088.2012.03.091.
[15] 何苗,王秀丽,祁海鸥,周阳,李漓,任春霞,姜文彬,魏建梅,许丽媛,刘敏君,张海燕.全国145家医院疼痛护理管理现状调查[J].中国护理管理,2023,23(10):1441-1446.DOI:10.3969/j.issn.1672-1756.2023.10.001.
[16] 陈羽双,杨斯钰,张叶霞,周乐山.老年人慢性疼痛管理的最佳证据总结[J].中华现代护理杂志,2021,27(7):922-929.DOI:10.3760/cma.j.cn115682-20200705-04231.
[17] 中华医学会老年医学分会,纪泉,易端,王建业,蹇在金,郑松柏,张存泰,于普林,樊碧发,中国医师协会疼痛科医师分会.老年患者慢性肌肉骨骼疼痛管理中国专家共识(2019)[J].中华老年医学杂志,2019,38(5):500-507.DOI:10.3760/cma.j.issn.0254-9026.2019.05.008.
[18] 万艳慧,吕桂兰,王珂,杜文娟,刘芳,张爱琴.脊髓损伤患者神经病理性疼痛护理干预最佳证据总结[J].中国实用护理杂志,2021,37(32):2511-2515.DOI:10.3760/cma.j.cn211501-20210514-01382.
[19] Chou R, Atlas S J. Subacute and chronic low back pain: Nonpharmacologic and pharmacologic treatment[J]. Lisa Kunins https://www. uptodate. com/contents/subacute-andchronic-low-back-pain-nonpharmacologic-and-pharmacologic-treatment, 2022.

[20] Richard-Lalonde M, Gélinas C, Boitor M, et al. The effect of music on pain in the adult intensive care unit: a systematic review of randomized controlled trials[J]. Journal of pain and symptom management, 2020, 59(6): 1304-1319. e6.
[21] 江丹丹,丁娟,肖继荣,姚小云.骨科患者围手术期疼痛管理的最佳证据总结[J].护理管理杂志,2022,22(4):290-295.DOI:10.3969/j.issn.1671-315x.2022.04.013.
[22] 刘伟红,李冰,孙永海.慢性疼痛病人参与式音乐治疗结合放松训练的 应用效果[J].中国疼痛医学杂志,2019,25(2):125-128.DOI:10.3969/j.issn.1006-9852.2019.02.010.
[23] 糖皮质激素在疼痛微创介入治疗中的应用——中国专家共识[J].中国疼痛医学杂志,2017,23(6):401-404.DOI:10.3969/j.issn.1006-9852.2017.06.001.
[24] Finnerup N B, Kuner R, Jensen T S. Neuropathic pain: from mechanisms to treatment[J]. Physiological reviews, 2020.
[25] Khasbage S, Shukla R, Sharma P, et al. A randomized control trial of duloxetine and gabapentin in painful diabetic neuropathy[J]. Journal of Diabetes, 2021, 13(7): 532-541.
[26] Kent C N, Park C, Lindsley C W. Classics in chemical neuroscience: baclofen[J]. ACS chemical neuroscience, 2020, 11(12): 1740-1755.
[27] 中国国家卫生健康委能力建设和继续教育中心疼痛病诊疗专项能力提升项目专家组.非阿片类镇痛药治疗慢性疼痛病中国指南[J].中华医学杂志,2023,103(39):3088-3102.DOI:10.3760/cma.j.cn112137-20230529-00876.